



AI 輔助以 CASP 與 CEBM 工具 進行實證文獻評讀之實務應用



邱于容 副教授 | 國防醫學大學公共衛生學院

2026 年 7 月 17 日



目錄

- 壹 教學目標
- 貳 CASP 與 CEBM 工具簡介
- 參 實證護理案例分析報告
- 肆 ebn-case-report skill 設定與使用教學
- 伍 案例演練：撰寫實證護理案例分析報告
- 陸 實證護理案例分析審查評核
- 柒 ebn-report-review skill 設定與使用教學
- 捌 案例演練：審查實證護理案例分析報告



教學目標

本課程說明如何運用 Claude 搭配 CASP 與 CEBM 文獻評讀工具，完成「三軍總醫院護理部實證護理案例分析報告」的撰寫與審查。

- ebn-case-report：協助撰寫實證護理案例分析報告
- ebn-report-review：協助審查與評分
- 示範一套從「寫」到「審」皆可重複操作的標準作業流程

△ 本教材以現行 Claude.ai 操作介面進行介紹，若介面版本更新導致步驟差異，請以實際畫面為準。



為什麼需要評讀工具

- 實證文獻評讀不能只憑「讀完後覺得寫得不錯」的主觀印象
- 提升評讀過程的客觀性、透明度與一致性
- 使不同評讀者評讀同一篇文獻時，能得到相近的結論



兩套工具的比較

比較項目	CASP RCT Checklist (2020年版)	牛津 CEBM 系統性回顧評讀工具
適用研究設計	隨機對照試驗 (RCT)	系統性回顧 / 統合分析
結構	11題，分A/B/C/D四大部分	5題 (Q/F/A/A/T)
核心提問	隨機分派是否恰當？盲化？結果精確度？當地適用性？	PICO是否清楚？檢索是否完整？納入標準是否合適？異質性如何？
回答方式	是 / 否 / 無法判斷 + 評述	是 / 否 / 不清楚 + 評論

💡 選對工具：「RCT」就用 CASP，「系統性回顧 / 統合分析」就用 CEBM。



三軍總醫院護理部實證護理案例分析報告格式

此表格是撰寫實證護理案例分析報告的格式，共六大類、15 個子項目。

類	子項目	百分比
(一) 案例介紹	臨床情境 (案例簡介/s/o/異常值/動機)	5
(二) 形成問題	臨床問題 / PICO / 問題類型	10
(三) 尋找最佳文獻證據	關鍵字與MeSH / 醫學主題詞畫面 / 搜尋策略 / 搜尋資料庫畫面 / 納入排除理由	25
(四) 評讀文獻	參考文獻證據等級 / 文獻摘要 / 文獻評析	36
(五) 證據應用轉譯過程	應用於護理過程 / 照護成果評值	20
(六) 結論	心得與實務建議	4



安裝 ebn-case-report skill

步驟 1 · 取得 Skill 檔案

透過課程頁面下載「ebn-case-report」skill 檔案。

步驟 2 · 啟用「Code execution and file creation」功能

點選左下角姓名 / 頭像 → Settings → Capabilities，開啟「Code execution and file creation」；此 skill 需連網查詢文獻，請一併開啟「Allow network egress」。

步驟 3 · 上傳 skill 至 Claude.ai

點選左側選單 Customize → Skills → 「+」，選擇下載的「ebn-case-report」skill 檔案上傳；完成後會出現在技能清單中。

💡 Skill 是邱于容副教授預先寫好的操作工具包，Claude 會照固定步驟與文獻評讀標準協助操作；觸發方式為直接輸入「/ebn-case-report」。



16 步驟操作流程

步驟	內容	操作重點
1	臨床情境	五要素 (簡介/S/O/異常值/動機) 缺一不可，AI會主動追問補齊
2-4	臨床問題 / PICO / 問題類型	AI會檢查前後是否邏輯一致，避免跳題
5	關鍵字與MeSH	AI會實際呼叫PubMed查證MeSH term是否真實存在，不是憑印象生成
6-8	文獻搜尋 (二級/一級/本土資料庫)	AI會實際執行Scite搜尋 + web_search查證，並誠實計算篇數
9	納入與排除理由	針對實際選出的候選文獻說明理由
10	文獻證據等級	依Oxford 2011分級表，對照問題類型判定
11	文獻摘要	APA格式，AI會提醒未能查證之處
12	文獻評析	依文獻研究設計選CASP或CEBM，逐題執行後歸納為有效性/重要性/應用性
13-15	應用於護理過程 / 成果評值 / 結論	須扣回案例與文獻，不可寫空泛套話
16	彙整成正式Word表格	全部確認後才執行，自動填入表格並輸出



使用AI核心原則

AI 僅能作為護理人員進行實證文獻評讀的輔助工具，使用者仍須親自閱讀原始文獻，並依據專業知識、臨床經驗及實際照護情境，逐項查核與修正 AI 產出的內容，才能提升評讀結果的正確性與報告品質。

- 一步一步來
- 絕不編造



使用 Claude 注意事項

注意事項	說明
模型選擇	用 Sonnet 系列即可。
額度 / 用量	每個案例建議開一個新對話，不要把多個案例塞進同一串對話；實際額度請至 Settings → Usage 查看即時進度條。
病人隱私	上傳或輸入案例資料前，務必先去識別化：不可包含病歷號、身分證字號、真實姓名等，改用化名與相對時間。
未查證標註	看到「未查證」標示，代表 AI 誠實承認的知識邊界，請務必自行複核後再處理。



實例演練

請使用以下示範案例（已去識別化）進行練習。

💡 林女士，68歲，因右膝退化性關節炎接受全膝關節置換術。術後第一天出現明顯疼痛、腫脹及活動受限，因害怕疼痛而不願下床及配合復健。右膝明顯腫脹，腿圍較左側增加5.5公分；右膝屈曲角度約45度。心跳102次/分、血壓156/88 mmHg。

討論問題（表單：<https://forms.gle/dEXJB5aVJYpHp7537>）



三軍總醫院實證護理案例分析審查評核表

審查評核項目及配分如下表，總分100分，60分（含）以上為通過。

類目	配分
（一）案例介紹	5
（二）形成問題	10
（三）尋找最佳文獻證據	25
（四）評讀文獻	36
（五）證據應用轉譯過程	20
（六）結論	4



退稿原因

符合以下任一情形即可考慮退稿：

- PICO 與臨床情境不符
- 個案照護期間超過二年
- 文獻與 PICO 不符
- 文獻搜尋呈現違反學術倫理（含洩漏單位）
- 格式不符（未評讀兩篇文章、未檢附 MeSH term 或資料庫搜尋畫面等）



安裝 ebn-report-review skill

步驟 1 · 取得 Skill 檔案

透過課程頁面下載「ebn-report-review」skill 檔案。

步驟 2 · 啟用「Code execution and file creation」功能

點選左下角姓名 / 頭像 → Settings → Capabilities，將「Code execution and file creation」開關切換為開啟。

步驟 3 · 上傳 skill 至 Claude.ai

點選左側選單 Customize → Skills → 「+」，選擇下載的「ebn-report-review」skill 檔案上傳；完成後會出現在技能清單中。

💡 Skill 是邱于容副教授預先寫好的操作工具包，Claude 會照固定步驟與審查評核標準協助操作；觸發方式為直接輸入「/ebn-report-review」。



評分流程與核心原則

這個 skill 引導審查者完成四個階段：

步驟 1．上傳報告

上傳要審查的報告內容（Word 檔案，或貼上文字）。

步驟 2．逐項評分 + 寫評語

對照評核表15個項目逐項評分，評語對應報告的實際內容。

步驟 3．檢查退稿條件

主動檢查是否已達退稿條件（如「未附截圖」），若有則停下詢問審查者要退稿還是依現有內容評分。

步驟 4．輸出評核表

輸出正式 xlsx 評核表，公式自動加總分數並判定通過 / 不通過。



使用 Claude 注意事項

注意事項	說明
模型選擇	用 Sonnet 系列即可。
額度 / 用量	每個案例建議開一個新對話；實際額度請至 Settings → Usage 查看即時進度條。
病人隱私	上傳或輸入案例資料前，務必先去識別化，改用化名與相對時間。
AI給的是建議評分	審查者仍須實際讀過報告內容，覆核 AI 給的分數與評語是否合理，AI 的輸出是輔助而非最終決議。
退稿裁量權在人不在AI	AI 只會主動提醒「這裡疑似觸及退稿條件」，最終要退稿還是評分，永遠由審查者本人決定。



案例演練

請沿用前一個演練產出的報告草稿（或使用上課提供的完整版林女士案例報告），操作 ebn-report-review skill 進行評分演練。

討論問題（表單：<https://forms.gle/jAohCaF7pXZByL6q8>）



謝謝聆聽

Q & A